RECOMENDACIONES Y EJERCICIOS TRAS LA ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA

Este documento es para pacientes intervenidos de Prótesis Total de Cadera (PTC). Da recomendaciones generales para después de la cirugía que incluye cómo reducir el riesgo de luxación, ejercicios progresivos para ayudarle a ganar fuerza y movilidad, e información sobre cómo conseguir el máximo beneficio de su prótesis.

Después de pasar por una cirugía de reemplazo de cadera, se espera que su estilo de vida sea muy parecido al de antes de la cirugía, pero sin el dolor. En términos generales esto es cierto, pero volver a sus actividades diarias llevará tiempo. Ser partícipe activo en el proceso de recuperación puede ayudarle a mejorar antes y asegurar un resultado más efectivo.

A pesar de que podrá retomar la mayoría de las actividades, es conveniente cambiar la manera en que las hace. Por ejemplo, tendrá que aprender nuevas maneras de agacharse para proteger su nueva cadera. Las sugerencias que encontrará aquí le ayudarán a convivir con la prótesis mientras retoma su rutina diaria de forma segura.

1. ALTA DEL HOSPITAL

Su ingreso en el hospital aproximadamente durará entre 2 y 4 días desde la intervención, dependiendo de la rapidez de su recuperación. Antes de que sea dado de alta del hospital, necesitará cumplir varios objetivos, como:

- Subirse y bajarse de la cama con ayuda.
- Tener un control del dolor aceptable.
- Caminar con un dispositivo de ayuda (un bastón, andador o muletas) sobre una superficie nivelada.
- Poder realizar los ejercicios domiciliarios explicados por su médico.
- Comprender cualquier precaución que le hayan dado sobre la prótesis para prevenir lesiones y asegurar una recuperación adecuada.

Cuando se le da el alta, el equipo de Traumatología le proveerá información de apoyo para su recuperación en casa. A pesar de que la tasa de complicaciones después de una prótesis total de cadera es baja, cuando ocurren estas complicaciones se puede prolongar o limitar la recuperación completa. Por eso conviene saber identificar las complicaciones posibles, aprendiendo las señales de una infección o coágulo de sangre.

Señales de advertencia de infección

- Fiebre persistente (más de 38ºC).
- Escalofríos.
- Aumento de enrojecimiento, sensibilidad o inflamación de la herida.
- Supuración de la herida.
- Aumento franco del dolor en la actividad y el descanso.

Señales de advertencia de un coágulo de sangre

- Dolor en la pierna o pantorrilla no relacionada a su incisión.
- Sensibilidad o enrojecimiento sobre o debajo de su rodilla.
- Inflamación severa de su muslo, pantorrilla, tobillo o pie.

En casos muy raros, un coágulo de sangre podría viajar a sus pulmones y poner en peligro la vida. Las señales de que un coágulo de sangre ha viajado a sus pulmones incluyen:

- Dificultad para respirar.
- Dolor repentino de pecho.
- Dolor de pecho localizado al toser.

¡Acuda a urgencias inmediatamente si muestra cualquiera de estas señales!

2. RECUPERACIÓN EN EL HOGAR

Necesitará un poco de ayuda en casa desde unos días hasta varias semanas después de su dada de alta. Antes de la cirugía, programe la ayuda de un amigo, familiar o cuidador para ayudarlo una vez vuelva a casa.

Preparación del hogar

Los siguientes consejos pueden hacer que la vuelta a casa sea más cómoda, e incluso pueden ser organizados antes de su cirugía:

- Reacomode los muebles de manera que pueda moverse con un bastón, andador o muletas. Usted podría cambiar habitaciones (hacer que la sala de estar sea su dormitorio, por ejemplo) para minimizar el uso de escaleras.
- Coloque artículos que usa frecuentemente (teléfono, mando de TV, gafas, jarra y vaso, material de lectura y medicamentos, por ejemplo) dentro de su alcance para no tener que estirarse o doblarse para alcanzarlos.
- Retire cualquier alfombra que pueda causar tropiezos. Asegure cables eléctricos alrededor del perímetro de la habitación.
- Obtenga una buena silla, una que sea firme y elevada. Este tipo de silla es más segura y cómoda que una silla baja y blanda. A ser posible, que tenga reposabrazos firmes.
- Instale una silla para duchas y alza de inodoro en el baño (se pueden conseguir en cualquier ortopedia).
- Use dispositivos de asistencia como un calzador de mango largo, una esponja de mango largo y algún instrumento para alcanzar artículos y así evitar agacharse demasiado.

3. CUIDADO DE LA HERIDA

Durante su recuperación domiciliaria, siga estas pautas para cuidar su herida y ayudar a prevenir infecciones:

Mantenga el área de la herida limpia y seca. Se aplicará un apósito en el hospital, el cual debe cambiarse tan a menudo como sea necesario. Habitualmente las curas de la herida se realizan cada 48-72h a cargo de su Centro de Salud. Puede ponerse en contacto con éste para concertar curas a domicilio. La retirada de puntos se recomienda hacerse a los 15-20 días, una vez asegurado el cierre completo de la herida.

Inflamación

Espere una inflamación leve/moderada de 3 a 6 meses después de la cirugía. Para reducir la inflamación, eleve su pierna ligeramente y aplique hielo.

Medicamentos

Tome todos los medicamentos según los recetó su médico. La medicación puede incluir analgésicos narcóticos y no narcóticos, anticoagulantes inyectables, ablandadores de heces y medicamentos protectores de estómago.

Asegúrese de hablar con su traumatólogo sobre todos sus medicamentos, incluyendo los fármacos de venta libre, suplementos y vitaminas. Su médico le dirá qué medicamentos de venta libre son seguros de tomar mientras usa analgésicos bajo receta.

Es especialmente importante prevenir que se desarrolle en su articulación artificial cualquier infección bacteriana. Su médico podría aconsejar que tome antibióticos cuando exista más probabilidad de una infección bacteriana, como cuando reciba tratamiento odontológico. Notifique a su dentista que usted tuvo un reemplazo de cadera.

Dieta

En el momento del alta, debería estar tomando una dieta normal. Además su médico podría recomendarle que tome suplementos de hierro y vitaminas.

Continúe bebiendo muchos líquidos, pero trate de limitar su consumo de café y evite el alcohol. Debe continuar cuidando su peso para evitar poner más estrés en la articulación. Evite el consumo de tabaco, al menos hasta que la herida esté completamente cicatrizada.

4. INCORPORACIÓN DE ACTIVIDADES NORMALES

Una vez que esté en casa, debería permanecer activo. La clave es no hacer demasiado, demasiado pronto. Mientras que es de esperar algunos días buenos y otros malos, debería notar una mejoría gradual con el tiempo. Por lo general, aplicarán las siguientes pautas:

Soporte del peso

Siga las instrucciones específicas al alta sobre el uso de un bastón, andador o muletas. El soporte total del peso podría permitirse inmediatamente o podría retrasarse durante varias semanas según el tipo de intervención realizada. Su traumatólogo le aclarará este punto antes del alta.

Caminar

Recomendamos inicialmente que use el andador o muletas tanto dentro como fuera de casa hasta que tenga la confianza suficiente como para moverse por dentro de casa con una o ninguna muleta. Fuera de casa, es recomendable mantener las dos muletas o el andador hasta que pueda deambular sin una cojera pronunciada, momento en el cual puede soltar una o ambas muletas.

- Al caminar, asegúrese que ambos pasos sean de la misma longitud.
- Trate de dedicarle el mismo tiempo a ambos pasos.
- Intente pisar primero con el talón y luego con el resto del pie.
- Gradualmente, puede incrementar la distancia del paseo o la intensidad del mismo.

Sentarse

Para sentarse, acérquese al asiento lo suficiente como para notarlo en la parte de atrás de las piernas. Suelte el andador o las muletas y apóyese en el reposabrazos del asiento con ambas manos. Adelante o estire ligeramente la pierna intervenida y proceda a sentarse despacio.

Para levantarse, comience estirando ligeramente la pierna intervenida y coja impulso con ambas manos en los respaldos del asiento. Una vez se incorpore compruebe que tiene equilibrio antes de soltar el reposabrazos y alcanzar el andador o las muletas.

No use el andador como apoyo para levantarse o incorporarse.

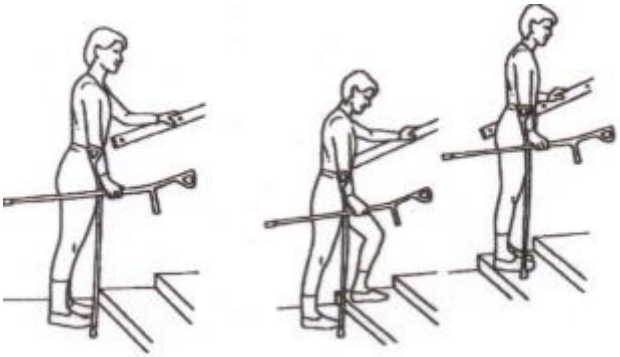
Escaleras

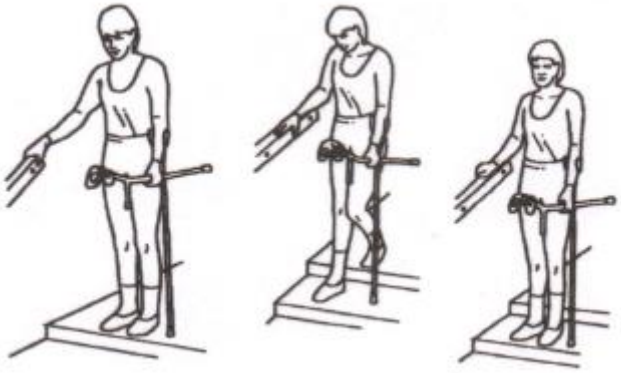
Las primeras 2-3 semanas, es conveniente evitar subir escaleras para evitar la inflamación y una potencial caída. Es conveniente ganar movilidad y fuerza primero.

Para comenzar a subir y bajar escaleras, es mejor hacerlo de peldaño en peldaño, tomándose su tiempo. Si tiene muletas, puede usar una como el apoyo de un lado y el pasamanos como el apoyo del otro.

Para subir escaleras, recomendamos usar primero la pierna no intervenida primero, situándola en el escalón siguiente. Tras esta sigue la pierna intervenida y la muleta.

Para bajar escaleras, recomendamos comenzar al contrario, apoyando la pierna intervenida primero junto con la muleta, seguido de la pierna no intervenida.





Conducir

En la mayoría de los casos, es seguro volver a conducir cuando ya no esté tomando analgésicos narcóticos y cuando la fuerza y reflejos han vuelto a su estado normal. Su médico lo ayudará a determinar cuándo es seguro volver a conducir, que suele ser generalmente a partir del mes desde la cirugía.

Actividad sexual

Por lo general, puede retomar su actividad sexual varias semanas después de la cirugía evitando los movimientos mencionados al final de este documento (*Qué hacer y no hacer para proteger su prótesis*).

Posición para dormir

Antes del alta, su médico le informará de las posiciones a evitar a la hora de dormir o incluso puede recomendarle dormir con una almohada entre sus piernas por un periodo de tiempo. Como norma general, se recomienda evitar dormir de lado durante las primeras 4 semanas.

Vuelta al trabajo

Según el tipo de actividades que usted realiza en el trabajo y la rapidez de su recuperación, podría llevar varias semanas antes de que pueda volver al trabajo. Su médico le aconsejará cuando es seguro retomar sus actividades normales de trabajo.

Deportes y ejercicios

Continúe haciendo los ejercicios recetados por su médico por lo menos durante 2 meses tras la cirugía. En algunos casos, su traumatólogo podría recomendar usar una bicicleta estática con sillín alto para ayudarle a mantener el tono muscular y su cadera flexible.

Tan pronto como su médico lo autorice, puede volver a realizar muchas de las actividades deportivas que disfrutaba antes de su reemplazo de cadera:

- Camine tanto como quiera, pero recuerde que caminar no es un sustituto de los ejercicios recetados por su médico y fisioterapeuta.
- Nadar es una actividad de bajo impacto excelente después de un reemplazo total de cadera; puede comenzar tan pronto se retiren los puntos y la herida sane.
- En general, las actividades físicas de bajo impacto, como jugar al golf y andar en bicicleta sobre terreno regular, ponen menos estrés en la articulación de la cadera y se prefieren sobre actividades de alto impacto como correr, jugar al pádel y esquiar.

Viajes en avión

No es recomendable volar en las primeras 6 semanas desde la cirugía debido al alto riesgo de trombosis. Las guías recomiendan comenzar con vuelos cortos (de hasta 4 horas) y posponer vuelos de mayor duración a partir de los 3 meses.

Los cambios de presión y la inmovilidad podrían causar que la articulación de su cadera se inflame, especialmente si todavía está sanando. Consulte a su médico antes de viajar en avión.

Cuando pase por seguridad, tenga en cuenta que la sensibilidad a detectores de metal varía y su articulación artificial podría activar la alarma. Informe al inspector sobre su prótesis de cadera antes de pasar por el detector metal.

5. QUÉ HACER O NO HACER PARA PROTEGER SU PRÓTESIS

Estas precauciones ayudarán a prevenir que su cadera nueva se disloque y a asegurar la curación adecuada. Aquí hay algunas precauciones comunes:

Qué no hacer

- No cruce sus piernas en las rodillas.
- No eleve su rodilla más arriba que su cadera.
- No se incline hacia delante cuando está sentado o mientras se sienta.
- No trate de levantar algo del suelo mientras está sentado.
- No gire sus pies excesivamente hacia dentro o hacia fuera cuando se doble la rodilla.
- No alcance sus mantas a los pies cuando esté acostado en su cama.
- No se flexione en la cintura más de 90 grados para recoger algo del suelo.

Qué hacer

- Mantenga la pierna afectada al frente mientras se sienta o se levanta.
- En caso de necesidad, arrodíllese sobre la rodilla de la pierna operada (el lado malo).
- Use hielo para reducir el dolor y la inflamación, pero recuerde que el hielo disminuirá la sensación. No aplique hielo directamente a la piel; use un paquete de hielo o envuélvalo en una toalla húmeda.
- Aplique calor antes de hacer ejercicio para asistir con la amplitud de movimiento. Use una almohadilla calentadora o toalla húmeda por 15 a 20 minutos.
- Disminuya la frecuencia de sus ejercicios si los músculos comienzan a doler, **¡pero no deje de hacerlos!**

EJERCICIOS

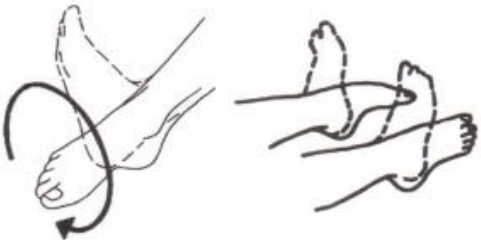
Apuntar ejercicios realizados en tabla adjuntada al final. Traer tabla a primera revisión para evaluación por su médico.

DÍA 0-3

Estos ejercicios se deben realizar regularmente durante el día para reducir el riesgo de trombosis en los miembros inferiores. Recomendamos la realización de este grupo de ejercicios al menos 3 veces al día.

a) Respiraciones profundas:
   - Inspire por la nariz, retenga en aire durante 2-3 segundos y exhale por la boca.
   - Haga 3 o 4 respiraciones profundas y luego relájese.
   - Repita otras 3 o 4 veces y vuélvase a relajar.
   - Repita una última vez (3 veces en total).

b) Ejercicios circulatorios:
   - Este ejercicio se realiza tumbado en cama.
   - Flexoextensión de tobillos.
   - Movimientos circulares de tobillos en ambas direcciones.
   - Haga un mínimo de **10 repeticiones** por cada ejercicio y por cada tobillo.

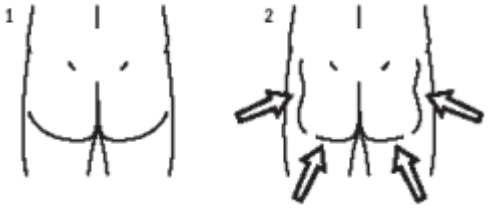


c) Flexión de cadera en cama:
   - Este ejercicio se realiza tumbado en cama.
   - Deslice el talón de la pierna intervenida hacia el glúteo, permitiendo que la rodilla y la cadera se doblen.
   - **Repita 10 veces**.

d) Abducción de cadera en cama:
   - Este ejercicio se realiza tumbado en cama.
   - Mantenga ambas piernas estiradas con los dedos del pie apuntando al techo durante todo el ejercicio.
   - Deslice la pierna intervenida hacia fuera, sin sobrepasar el borde de la cama y vuelva a la posición inicial. Relajar la musculatura al terminar.
   - **Repetir 10 veces.**

e) Contracción isométrica de cuádriceps:
   - Este ejercicio se realiza tumbado en cama.
   - Contraiga los cuádriceps (músculos del muslo) empujando la parte de atrás de la rodilla contra la cama y apuntando los dedos del pie hacia el techo.
   - Aguante esa contracción durante 5 segundos y relájese completamente.
   - **Repetir 10 veces.**

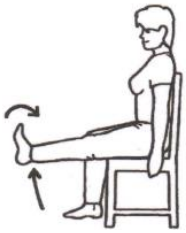
f) Contracción isométrica de glúteos:
   - Contraiga los glúteos como queriendo juntarlos.
   - Aguante esa contracción durante 5 segundos y relájese completamente.
   - **Repetir 10 veces.**



DÍA 4-30

Recomendamos la realización de estos ejercicios 3 veces al día.

a) Cuádriceps en rango completo:

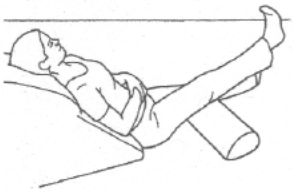


- Sentado en una silla, extienda la rodilla y apunte con los dedos del pie al techo.
- Aguante durante 10 segundos y luego relaje la rodilla paulatinamente.
- **Repetir 10 veces.**

b) Flexión de rodilla sentado:

- Sentado en una silla, con el pie en el suelo, doblar la rodilla tanto como sea posible.
- Aguantar 2-3 segundos y luego estirar la rodilla
- **Repetir 10 veces**.

c) Cuádriceps en rango final:



- Tumbado y con una toalla debajo de la rodilla.
- Contraer los músculos del muslo para levantar el talón de la cama.
- Aguantar la contracción durante 10 segundos y relajar.
- **Repetir 10 veces**.

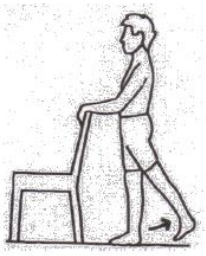
d) Abducción en bipedestación:

- De pie con agarre en un soporte fijo.
- Manténgase sobre su pierna sana y separe la pierna intervenida del cuerpo.
- Relaje suavemente hasta juntar de nuevo la pierna.
- Mientras haga este ejercicio, mantenga la punta del pie apuntando al frente e intente mantener el tronco recto.
- **Repetir 10 veces**.

e) Flexión de cadera en bipedestación:

- De pie con agarre en un soporte fijo.
- Doble la rodilla de la pierna intervenida hacia el pecho hasta alcanzar 90 grados.
- Relajar suavemente estirando la rodilla
- **Repetir 10 veces**.

f) Extensión de cadera en bipedestación:



- De pie con agarre en un soporte fijo.
- Estire la pierna intervenida recta hacia la espalda, tanto como sea posible.
- Aguante la contracción un par de segundos antes de bajar.
- Mientras haga este ejercicio, mantenga el tronco recto.
- **Repetir 10 veces**.

REGISTRO DE EJERCICIOS POSTOPERATORIOS DE PROTESIS DE CADERA TOTAL

	1ª SEMANA						
Día 0-3	1	2	3	4	5	6	7
Respiraciones profundas							
Movimientos circulatorios							
Flexión de cadera en cama							
Abducción de cadera en cama							
Contracción isométrica de cuádriceps							
Contracción isométrica de glúteos							
Día 4-9	1	2	3	4	5	6	7
Cuádriceps en rango completo							
Flexión de rodilla sentado							
Cuádriceps en rango final							
Abducción en bipedestación							
Flexión de cadera en bipedestación							
Extensión de cadera en bipedestación							
	2ª SEMANA						
Día 8-14	8	9	10	11	12	13	14
Cuádriceps en rango completo							
Flexión de rodilla sentado							
Cuádriceps en rango final							
Abducción en bipedestación							
Flexión de cadera en bipedestación							
Extensión de cadera en bipedestación							
	3ª SEMANA						
Día 15-21	15	16	17	18	19	20	21
Cuádriceps en rango completo							
Flexión de rodilla sentado							
Cuádriceps en rango final							
Abducción en bipedestación							
Flexión de cadera en bipedestación							
Extensión de cadera en bipedestación							
	4ª SEMANA						
Día 22-28	22	23	24	25	26	27	28
Cuádriceps en rango completo							
Flexión de rodilla sentado							
Cuádriceps en rango final							
Abducción en bipedestación							
Flexión de cadera en bipedestación							
Extensión de cadera en bipedestación							
	5ª SEMANA						
Día 29-35	29	30	31	32	33	34	35
Cuádriceps en rango completo							
Flexión de rodilla sentado							
Cuádriceps en rango final							
Abducción en bipedestación							
Flexión de cadera en bipedestación							
Extensión de cadera en bipedestación							

Anotar con una X una vez cumplido el objetivo de 3-4 veces al día. Puede ser de utilidad traer esta hoja a la primera revisión.